

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

1. Introducción y relevancia clínica

El **Trastorno del Espectro Autista (TEA)** es un **trastorno del neurodesarrollo** caracterizado por **déficits persistentes en la comunicación social** y por **patrones restringidos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades**.

A diferencia de los antiguos subtipos (autismo infantil, Asperger, etc.), el **DSM-5-TR** y la **CIE-11** lo engloban como un **continuo dimensional**, que varía en gravedad y nivel de apoyo requerido.

Su relevancia clínica radica en:

- **Alta prevalencia:** estimada entre **1–2%** de la población infantil, con aumento sostenido por mejor diagnóstico.
- **Inicio precoz:** antes de los 3 años de edad.
- **Importancia del diagnóstico temprano:** permite intervención oportuna y mejora del pronóstico funcional.
- **Impacto familiar y social significativo**, que exige un enfoque multidisciplinario y educativo.

□ En el EUNACOM, las preguntas sobre TEA suelen centrarse en:

- Identificación de signos precoces.
- Diferencias con retraso global del desarrollo y TDAH.
- Derivación oportuna y manejo en APS.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El TEA es un **trastorno neurobiológico del desarrollo cerebral**, no una enfermedad adquirida.

Su fisiopatología implica una combinación de **factores genéticos y ambientales**, que alteran la **conectividad neuronal** y los **circuitos sociales del cerebro**.

2.1. Bases neurobiológicas

- **Genética:**

- Heredabilidad estimada en **70–90%**.
- Asociado a más de 100 genes implicados en sinapsis neuronal (SHANK3, MECP2, NRXN1, etc.).
- Riesgo aumentado si hay hermano con TEA (~10%).

- **Neurodesarrollo:**

- Alteraciones en la **conectividad funcional** de la amígdala, corteza prefrontal y cerebelo.
- Reducción del procesamiento social y de la teoría de la mente.

- **Factores ambientales:**

- Edad paterna avanzada, exposición prenatal a valproato, infecciones virales gestacionales.
- **No hay evidencia** de relación con vacunas (refutado científicamente).

□ Conceptualmente, el TEA se entiende como una “**neurodivergencia**”, no una enfermedad psiquiátrica tradicional, sino una forma distinta de procesar la información social y sensorial.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Núcleos clínicos del TEA (DSM-5-TR)

A. Déficits persistentes en comunicación e interacción social

1. Dificultad para la reciprocidad social o emocional (p. ej., no responde al nombre, evita contacto visual).
2. Problemas en la comunicación no verbal (gestos, expresiones faciales).
3. Dificultades para desarrollar, mantener o comprender relaciones sociales.

B. Patrones restringidos, repetitivos de comportamiento, intereses o actividades

1. Movimientos o habla estereotipada (aleteo, ecolalia).
2. Insistencia en rutinas o resistencia al cambio.
3. Intereses fijos o altamente específicos (p. ej., obsesión por los trenes o números).
4. Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales (ruidos, luces, texturas).

El diagnóstico requiere la presencia de **ambos núcleos**, con inicio en el periodo temprano del desarrollo y deterioro funcional significativo.

Retraso global del desarrollo (RGD)	Déficit en múltiples áreas, pero con comunicación social proporcional al nivel cognitivo.
--	---

Trastorno específico del lenguaje	Retraso del habla, pero buena intención comunicativa.
--	---

TDAH	Impulsividad y desatención, pero adecuada reciprocidad social.
-------------	--

Trastorno de ansiedad social	Miedo al juicio, pero deseo de interacción presente.
-------------------------------------	--

Esquizofrenia infantil	Inicio posterior (después de 7 años), presencia de delirios o alucinaciones.
-------------------------------	--

☐ El signo más orientador en TEA es la **ausencia de reciprocidad social y comunicación espontánea**, más que el retraso del lenguaje en sí.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Evaluación clínica

El diagnóstico es **clínico**, basado en observación conductual e historia evolutiva detallada.

4.2. Herramientas diagnósticas estandarizadas

- **M-CHAT-R/F**: test de tamizaje entre 16–30 meses (en controles de niño sano).
- **ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule)**: observación estructurada (nivel especializado).
- **ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised)**: entrevista semiestructurada para padres.
- **EEDP / TEPSI**: útiles para valorar el desarrollo global.

En Chile, el **MINSAL** recomienda la aplicación del **M-CHAT-R/F** en controles de salud infantil, con derivación al COSAM o neuropsiquiatría ante sospecha.

4.3. Exámenes complementarios

Se solicitan solo para descartar etiologías secundarias o comorbilidades:

- **Audiometría / otoemisiones acústicas:** descartar hipoacusia.
 - **Evaluación genética (microarray, X frágil, MECP2):** ante dismorfias o retardo severo.
 - **EEG o RM cerebral:** si hay crisis epilépticas o signos neurológicos.
 - **Exámenes metabólicos:** solo si hay sospecha clínica (retraso grave, regresión, dismorfias).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

El tratamiento del TEA es **multidisciplinario, individualizado y precoz**.

El objetivo es **potenciar la comunicación, autonomía y adaptación social**.

No existe cura, pero las intervenciones tempranas mejoran significativamente la funcionalidad.

5.2. Intervenciones psicoeducativas y conductuales

Son la base del tratamiento y deben iniciarse idealmente antes de los 3 años.

Intervención	Objetivo	Evidencia
Terapia conductual intensiva (ABA: Applied Behavior Analysis)	Reforzar conductas adaptativas, reducir conductas problema.	Alta (Nivel 1A).

Intervenciones en comunicación social (TEACCH, Denver, Early Start Denver Model)	Estructurar rutinas y promover interacción social.	Alta.
Terapia del lenguaje y fonoaudiología	Desarrollar comunicación verbal o alternativa.	Alta.
Terapia ocupacional / integración sensorial	Manejar hipersensibilidad y motricidad fina.	Moderada.
Psicoeducación familiar	Enseñar estrategias conductuales y reducir estrés parental.	Fundamental .

5.3. Manejo farmacológico (solo coadyuvante)

No existen fármacos para “curar” el autismo; se tratan los **síntomas asociados**:

Síntoma / conducta	Fármaco	Evidencia / precauciones
Irritabilidad / agresividad	Risperidona, aripiprazol	Aprobados por FDA; vigilar efectos metabólicos.
Ansiedad / depresión	ISRS (sertralina, fluoxetina)	Dosis bajas; respuesta variable.
Hiperactividad / impulsividad	Metilfenidato o atomoxetina	Útil si hay TDAH comórbido.
Insomnio	Melatonina	Segura y eficaz.

❑ En Chile, el **MINSAL** prioriza la **intervención psicoeducativa** y el acceso a apoyos escolares (Programa PIE, Ley TEA 21.545 de 2023).

5.4. Coordinación intersectorial

- **Salud:** diagnóstico y seguimiento clínico (CESFAM, COSAM, neuropediatría).
 - **Educación:** inclusión escolar y adaptaciones curriculares (Programa de Integración Escolar, PIE).
 - **Desarrollo Social:** apoyo a cuidadores (Chile Crece Contigo, Ley TEA).
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Comorbilidades frecuentes

- TDAH (30–50%).
- Trastornos de ansiedad (40%).
- Trastornos del sueño.
- Epilepsia (20–30%).
- Déficit intelectual (hasta 40%).

6.2. Pronóstico

Depende del nivel de apoyo requerido:

- **Nivel 1 (leve):** independiente con apoyo educativo.
- **Nivel 2 (moderado):** requiere apoyo frecuente.
- **Nivel 3 (severo):** dependencia permanente.

Factores de buen pronóstico:

- Lenguaje funcional adquirido antes de los 5 años.
- Cociente intelectual normal.
- Intervención temprana.

- Participación familiar activa.

□ Con intervención precoz, el 30–50% de los niños logra autonomía social parcial o completa.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas clínicas

1. El TEA se define por **déficit social y conductas repetitivas**, no solo por retraso del lenguaje.
 2. El **M-CHAT-R/F** es el test de tamizaje recomendado en Chile entre los 16–30 meses.
 3. El **tratamiento es conductual y educativo**, no farmacológico.
 4. Los ISRS o antipsicóticos se usan solo para síntomas asociados.
 5. El **diagnóstico es clínico** y debe basarse en observación evolutiva.
 6. La **Ley TEA (2023)** garantiza inclusión educativa y atención integral en Chile.
 7. Evitar atribuir el TEA a causas no comprobadas (vacunas, alimentación, etc.).
-

□

Errores comunes

- Diagnosticar TEA solo por retraso del lenguaje.
- No diferenciar TEA de retraso global del desarrollo.
- Iniciar medicación sin intervención psicoeducativa.
- No derivar oportunamente al COSAM o neuropediatría.
- No incluir a la familia en el tratamiento.
- Etiquetar precozmente sin observación longitudinal.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **Trastorno del Espectro Autista (TEA)** es un trastorno del neurodesarrollo con **déficits en interacción social y conductas repetitivas**.
2. El diagnóstico es **clínico**, apoyado por herramientas como el **M-CHAT-R/F** y entrevistas estructuradas.
3. El tratamiento es **multidisciplinario**, centrado en **intervención conductual, lenguaje y psicoeducación familiar**.
4. Los **fármacos son coadyuvantes**, solo para controlar síntomas específicos.
5. La **detección temprana (antes de los 3 años)** mejora el pronóstico funcional.
6. La **Ley TEA (21.545)** garantiza en Chile inclusión educativa y atención integral.
7. El médico de APS debe **tamizar, contener y derivar precozmente** al equipo especializado.